

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
10/07/2023	10/07/2025	nº 02	nº 37	01 à 13
Nome do Procedimento: Limpeza, desinfecção, preparo e esterilização de artigos em saúde				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia				
Serviço: Todas as Unidades de Saúde				
Executantes: Enfermeiro, Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Técnico de Saúde Bucal				
Objetivo: Orientar os profissionais quanto a limpeza, desinfecção e esterilização correta de materiais e instrumentais de saúde				
Recursos necessários: ✓ Detergente enzimático e neutro; ✓ Escovas específicas para limpeza de artigos médicos; ✓ Desinfetante químico na forma líquida; ✓ Fita adesiva para autoclave (zebrada); ✓ Embalagem para embalar material (papel crepado, manta de sms, papel grau, campo de algodão); ✓ Autoclave; ✓ Teste biológico; ✓ Expurgo equipado; ✓ Armário para guarda e armazenamento; ✓ Caneta; ✓ Folha de registro e controle de esterilização; ✓ Integrador químico; ✓ Pacotes de gaze.				

CONCEITO

1 Limpeza

É a remoção mecânica de sujidade. É realizada pela aplicação de energia mecânica (fricção), química (soluções detergentes, desincrustantes ou enzimáticas) ou térmicas.

2 Desinfecção

É o processo de eliminação de microorganismos presentes nos artigos e objetos inanimados mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos. Este processo é subdividido em 03 níveis:

- ✓ Alto (destrói quase todos os tipos de microrganismos, incluindo alguns esporos). Compreende ainda o processo de esterilização em autoclave a vapor dos materiais previamente embalados;
- ✓ Intermediário (não possui ação contra esporos, mas destrói vírus e microbactérias);
- ✓ Baixo (não possui ação contra esporos, vírus não lipídicos e microbactérias).

3 Esterilização

É o processo pelo qual os microrganismos são mortos a tal ponto que não se possa detectá-



los no meio padrão de culturas em que previamente os agentes haviam proliferado.

4 Reprocessamento

Processo a ser aplicado em artigos odonto-médico-hospitalares para sua reutilização incluindo limpeza, desinfecção, preparo, embalagem, rotulagem, esterilização, testes biológicos e químicos, análise residual do agente esterilizante, que garanta o desempenho e a segurança. Este processo não pode ser aplicado a artigos de uso único.

5 Reesterilização

É o processo de esterilização de artigos já esterilizados, mas não utilizados. Este processo está indicado caso ocorram situações que comprometam a segurança da esterilização inicial (desde que estejam dentro do prazo de validade do produto ou da esterilização).

6 Classificação de Artigos em Serviço de Saúde

Os artigos em Serviço de Saúde são classificados de acordo com os riscos potenciais de transmissão de infecção para os pacientes e para definição dos processos a que serão submetidos após seu uso, da seguinte forma:

- a) **Artigos críticos:** são utilizados em procedimentos invasivos com penetração em pele ou mucosas, tecidos e órgãos e sistema vascular incluindo também todos os artigos ou produtos a eles conectados. Estes artigos após limpeza devem ser submetidos à **ESTERILIZAÇÃO**;
- b) **Artigos semicríticos:** entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras, sem penetração. Estes artigos após limpeza devem ser submetidos à **DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL** ou **ESTERILIZAÇÃO**;
- c) **Artigos não críticos:** entram em contato com a pele íntegra e também aqueles que não entram em contato direto com o paciente. Estes artigos requerem **LIMPEZA** após seu uso e dependendo do que destina seu último uso devem ser submetidos à **DESINFECÇÃO DE BAIXO** ou **MÉDIO NÍVEL**.

Nota

Produtos e artigos semicríticos, utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia, devem ser submetidos a limpeza e no mínimo desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes (desinfecção química), ou processo de termo desinfecção, obrigatoriamente.

7 Área Técnica

As unidades deverão possuir estrutura física separada para área de recebimento do material sujo e higienização, e área limpa onde os materiais serão preparados, embalados e esterilizados, sendo o fluxo de entrada e saída de materiais unidirecional, não sendo permitido o acondicionamento dos materiais limpos e higienizados ou esterilizados no mesmo local onde há material sujo. Separam-se em:

- a) **Área suja:** destinada ao recebimento e separação dos materiais sujos advindos dos setores de assistência. Local onde é realizado o processo de limpeza, desinfecção e secagem dos

instrumentais. Os profissionais da saúde deverão trabalhar paramentados com gorro, máscara, luva de borracha cano longo, avental impermeável, óculos de proteção e sapato fechado;

- b) **Área limpa:** local destinado aos processos de separação dos instrumentais para os pacotes e embalagem, conferência da limpeza, funcionalidade e integridade dos artigos. Assim como empacotamento, selagem das embalagens e esterilização. Os profissionais deverão trabalhar paramentados com gorro, avental, luva de procedimento e sapato fechado;
- c) **Área de guarda e distribuição de artigos esterilizados:** local destinado à guarda dos instrumentais esterilizados e dispensação dos mesmos, em local protegido de umidade, preferencialmente em armário fechado, ou em caixas plásticas com tampa, com disponibilidade de lavatório ou pia para a lavagem das mãos.

Nota

O processo de limpeza, desinfecção e esterilização consta de várias etapas, que devem ser seguidas para o preparo e processamento de todos os materiais conforme sua classificação. As etapas do processo devem seguir o fluxo sempre que o material se enquadrar no método de processamento específico.

DESCRIÇÃO

1 Etapas do processo de limpeza, desinfecção, preparo e empacotamento e esterilização

1.1 Limpeza manual

- ✓ Deve ser realizada imediatamente após o uso do artigo com auxílio de acessório não abrasivo detergente neutro ou enzimático. Caso não seja possível, colocar o material totalmente submerso em água potável, para evitar o ressecamento da sujidade e maior dificuldade para a remoção posterior;
- ✓ Para todos os artigos que entram em contato direto com o paciente, independentemente de serem artigos críticos ou não, utilize detergente enzimático. Para itens que não entram em contato direto com o paciente, porém são itens de apoio à assistência, utilizar processo de limpeza com detergente neutro (água e sabão) e proceder a secagem e desinfecção quando esta for indicada com álcool 70%;
- ✓ Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados: gorro, máscara e óculos de proteção, avental impermeável, luva de borracha, sapato fechado preferencialmente cano longo;
- ✓ Certificar-se que o detergente enzimático esteja diluído na concentração correta de acordo com o fabricante, e preferencialmente ser realizada em água morna, cabendo ao profissional certificar-se o modo de diluição nas instruções do fabricante, e dentro do prazo de validade do produto;
- ✓ Abrir todos os instrumentais e artigos a serem higienizados, e desmontar quando houver mais de uma peça, de modo que o instrumental tenha contato com o detergente enzimático em toda a superfície;
- ✓ Lavar peça por peça com escova apropriada, friccionando delicadamente o artigo, dentro de uma solução de detergente ou sob água corrente para evitar a formação de aerossóis com micro-organismos;
- ✓ A escova deve passar por inspeção visual sempre que for utilizada, cabendo ao profissional que irá utilizar, verificar se a mesma encontra-se em condições de uso, cerdas viáveis e sujidade aderida, devendo ser substituída sempre que o profissional considerar a mesma sem condições de uso;



- ✓ A escova ainda, deve passar por processo de limpeza e desinfecção ao final do dia, sendo lavada com água e sabão e colocada submergida em solução de hipoclorito, até o próximo dia a ser utilizada;
- ✓ As pinças Backaus devem ser abertas, limpas com cuidado, enxaguadas e fechadas logo após a limpeza;
- ✓ Realizar o enxágue copioso;
- ✓ Verificar a presença de sujidades e repetir a limpeza quando observadas sujidades visíveis;
- ✓ Encaminhar para a área de preparo todos os itens que necessitem de esterilização e desinfecção química.

1.2 Desinfecção de nível intermediário

Podem ser utilizados nesse processo o álcool etílico e hipoclorito de sódio de acordo com o tipo de material e seu uso.

Incluem-se neste processo: bandejas, cubas (não componentes de kit como cateterismo ou acessos vasculares), comadres, papagaios, inaladores, látex e extensores de ar e oxigênio, traqueias, máscaras, sistema de ventilação máscara válvula (ambú), artigos plásticos termo sensíveis.

1.2.1 Álcool

Álcool etílico hidratado a 70%, tem maior atividade germicida, menor custo e toxicidade por não deixar resíduos no material após a desinfecção e secagem. Indicado para desinfecção intermediária de artigos e superfícies (utilizar conforme a classificação de artigos e processos de desinfecção descrito anteriormente), com exposição de 10 minutos, ou três aplicações sequenciais de álcool 70% (aplicar álcool 70%, esperar secar sozinho e repetir três vezes a aplicação, não necessita de enxágue).

Quadro 01 – Artigos e superfícies que podem ser submetidos a desinfecção com álcool

Artigos e superfícies que podem ser submetidos a desinfecção com álcool
• Ampolas e vidros; • Termômetros; • Estetoscópios; • Otoscópios; • Mesas de exames; • Equipamentos metálicos de cozinha, lactário, bebedouros e áreas de alimentação; • Macas, camas; • Pratos e base de balança; • Bancadas; • Partes metálicas de incubadoras; • Artigos metálicos que não entrem em contato com mucosas; • Superfícies externas de equipamentos metálicos.

Fonte:

Cuidados especiais

- ✓ Pode ser usado na desinfecção concorrente de superfícies e movelaria (entre cirurgias, entre exames, após o uso do colchão, de troca de fraldas, etc.);
- ✓ É contraindicado o uso em acrílico, borrachas e tubos plásticos pois causam o enrijecimento do material e consequente quebra do produto;
- ✓ Evitar o uso em lentes e telas de monitores e equipamentos, pois pode danificar a lente causando infiltração e danos as lentes;
- ✓ O uso de álcool para desinfecção de artigos só deve ser utilizado quando não houver



indicação de outro método de desinfecção, ou o material não estiver relacionado diretamente à assistência.

1.2.2 Hipoclorito de sódio

Indicado para a desinfecção de artigos não-críticos ou semicríticos quando a total ausência de sujeira, e pode ser utilizado para descontaminação de superfícies em unidades críticas, conforme o tempo de ação na tabela abaixo:

Quadro 02 –

Material	Tempo de Exposição	Concentração
Material de inaloterapia e oxigenoterapia	60 minutos	1% de cloro ativo
Artigos não metálico	60 minutos	1% de cloro ativo

Fonte:

A desinfecção de médio nível com hipoclorito a 1%, pode ser realizada usando recipiente de vidro ou plástico opaco tampado para imersão dos artigos. Manter a imersão por um tempo mínimo de exposição de 30 minutos.

A validade máxima da solução em uso é de 24 horas, e deve obrigatoriamente ser mantida em recipiente com proteção a luz (não utilizar material transparente ou claro, que permita a passagem da luz, e sempre com tampa), entretanto, orienta-se a troca a cada 12 horas.

Desprezar a solução mesmo que não seja utilizado. Possui baixo risco de toxicidade, porém salienta-se a necessidade do uso de EPI (máscara cirúrgica, óculos de proteção ou protetor facial, avental impermeável, luvas de borracha de cano longo, sapato fechado impermeável), pois pode causar e queimadura química na mucosa nasal por inalação prolongada, principalmente com o produto concentrado, antes da diluição.

Todas as peças submetidas a esse tipo de desinfecção requerem enxágue abundante e posterior secagem completa incluindo vias internas e lúmens (preferencialmente com jato de ar comprimido).

1.3 Desinfecção de alto nível

Incluem-se nesse processo: materiais odontológicos (seringa de ar, brocas, moldeira), lâminas de laringoscópio, equipamento de terapia respiratória, anestesia e endoscópio.

1.3.1 Ácido Peracético

Germicida classificado como esterilizante e desinfetante. Promove menor agressão ao meio ambiente por conta da sua decomposição em água, ácido acético, oxigênio e peróxido de hidrogênio.

Possui ação em matéria orgânica mesmo em baixas temperaturas, porém, pode corroer alguns metais, sendo desaconselhado seu uso sempre que o artigo possuir partes metálicas, pois reduz a vida útil do artigo, salvo quando for utilizado solução anticorrosiva.

O produto, promove a desinfecção de alto nível em aproximadamente 15 minutos, portanto, não considerar nenhum item submetido a este método como esterilizado.

Possui baixo potencial tóxico para o profissional que o manipula, não dispensando, contudo, a necessidade do uso de EPI (máscara cirúrgica, óculos de proteção ou protetor facial, avental impermeável, luvas de borracha de cano longo, sapato fechado impermeável), e salienta-se que pode causar lesão ocular grave em caso de exposição ocupacional ao produto.

Cabe ao responsável pelo processo de desinfecção a monitorização dos parâmetros indicadores de efetividade para artigos semicríticos, no mínimo uma vez ao dia, antes do início das atividades, utilizando a fita indicadora que é disponibilizada junto com o produto, e observar a

durabilidade da solução, que deve ser descartada a cada 5 dias, independente do tempo de uso efetivo da solução.

Todas as peças submetidas a esse tipo de desinfecção requerem enxágue abundante e posterior secagem completa incluindo vias internas e lúmens (preferencialmente com jato de ar comprimido).

Nota

A esterilização química de artigos de saúde foi proibida pela Anvisa, na RDC nº 8/2009, portanto, este método só é indicado para desinfecção de artigos.

1.3 Preparo e empacotamento

Esta fase consiste na secagem, preparo e acondicionamento dos materiais de acordo com o tipo de material e processamento, em invólucro compatível com o processo e o material. Tem como objetivo manter a esterilidade do artigo, a vida útil, condição para transporte e o armazenamento até sua utilização, favorecendo transferência asséptica, sem risco de contaminação.

Deve ser realizado em todos os artigos que passam por processo de desinfecção e esterilização.

Recomendações

- ✓ Realizar higienização das mãos antes de iniciar o procedimento;
- ✓ Utilizar EPI – gorro, máscara, avental, luva de procedimento não estéril e sapato fechado;
- ✓ Separar e conferir peça por peça, estado de conservação para detectar se há sujidade, ferrugem, trincas, manchas e outros defeitos, separar todas as peças com defeitos para manutenção ou descarte, e devolver a área suja o que apresentar sujidade aparente;
- ✓ Secar os instrumentais individualmente, se houve ar comprimido disponível utilizá-lo;
- ✓ Separar a embalagem de acordo com tamanho, tipo de material e selecionar os materiais para cada pacote conforme o quadro 03.

Quadro 03 – Montagem de Pacotes

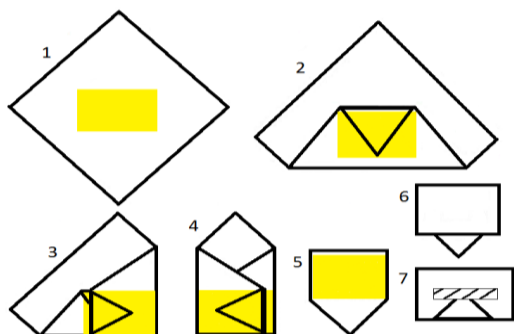
Tipo de Pacote	Instrumental	Material
Curativo	• 1 pinça dente de rato com trava • 1 pinça anatômica sem trava • 1 tesoura	• 10 gaze (separadas em duas pilhas de 5)
Retirada de pontos	• 1 pinça dente de rato com trava • 1 pinça anatômica sem trava • 1 tesoura íris ou cabo de bisturi	• 10 gaze (separadas em duas pilhas de 5)
Cateterismo vesical	• 1 cuba rim • 1 cuba redonda • 1 pinça (com ou sem dente)	• 10 gaze (dentro da cuba redonda)
Implante de DIU	• 1 histerômetro • 1 pinça pozzi • 1 pinça cheron	• 10 gaze
Pacotes de gaze	-----	• 10 gaze

Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial (NGA), 2023



- ✓ Se houver materiais perfurantes, cortantes ou perfuro cortantes, proteger as pontas com gaze. Caso o material utilizado seja o papel crepado, preferencialmente embalar em duas camadas;
- ✓ Arrumar os instrumentais de modo padrão, com todos os cabos para o mesmo lado, e mantendo sempre o mesmo número de peças para o mesmo tipo de pacote;
- ✓ Quando houver grau cirúrgico disponível, manter os cabos voltados para a borda de abertura do pacote;
- ✓ Pinças e tesouras curvas devem ser embaladas com a curvatura voltada para cima;
- ✓ Cubas com a abertura voltadas para baixo;
- ✓ Para grau cirúrgico, manter de 3 a 5 centímetros de borda para abertura;
- ✓ Embalar os instrumentais e artigos com papel crepado conforme técnica do envelope (figura 01);
- ✓ Fechar os pacotes embalados com o papel crepado utilizando a fita adesiva para autoclave (zebrada), sendo uma fita considerada como um indicador químico classe 1 termocrômico. Tem como objetivo identificar e diferenciar os produtos processados adequadamente e os que não foram em todas as cargas;
- ✓ Identificar o material escrevendo sobre a fita adesiva as informações: tipo de material ou nome do produto, número de lote, método de esterilização, validade, nome do responsável pelo fechamento do pacote e data de esterilização;
- ✓ Encaminhar para esterilização;
- ✓ Materiais de inaloterapia e oxigenoterapia deverão ser embalados em sacos plásticos, individualmente após a secagem completa do material, e receberem a identificação igual a de produtos esterilizados, identificando o processo de desinfecção com solução química.

Figura 01 – Técnica de empacotamento de material



Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial (NGA), 2023

Cuidados Especiais

- ✓ Descartar embalagens furadas, rasgadas e molhadas. É necessário reembalar e refazer o processo de esterilização;
- ✓ Os pacotes devem ser firmes e com dobras justas e próximas ao material;
- ✓ Identificar a embalagem antes de fixar a fita adesiva no pacote, para melhor estabilidade da escrita, evitando pressão com a ponta da caneta e possível perfuração;
- ✓ Inspeccionar todos os pacotes visualmente antes e depois do preparo e esterilização.

Nota: Pacotes já processados não poderão ser reutilizados.

1.4 Desinfecção de Alto Nível: Esterilização

Indicada para esterilização de artigos críticos termo resistentes, comumente os artigos metálicos e instrumentais cirúrgicos.

Recomendações

- ✓ Lavar as mãos;
- ✓ Revisar as condições das embalagens e identificação dos materiais;
- ✓ Separar e refazer a embalagem em caso de rasgos, perfurações e rupturas, e checar identificação complementando dados sempre que estiver faltando informações do processo;
- ✓ Selecionar os materiais/instrumentais conforme tipo de carga (leve 121°C e padrão 134°C);
- ✓ Verificar o nível de água no reservatório da autoclave. Se em excesso, provoca umidade na embalagem e transbordamento, se abaixo do nível pode queimar os pacotes;
- ✓ Dispor os pacotes dentro da câmara, preferencialmente lateralizados e não sobrepostos, deixando espaços entre eles, para penetração do vapor;
- ✓ Caso haja necessidade de sobreposição, colocar os pacotes mais leves sobre os mais pesados;
- ✓ O pacote desafio consiste em um pacote comum (preferencialmente gaze), porém contendo um integrador classe 5, que deve ser aberto ao final do processo de esterilização. Inserir pacote desafio ao centro da autoclave, em meio aos pacotes dentro da câmara;
- ✓ As embalagens que contenham recipientes como jarros, bacias, cubas, devem ser colocados em posição horizontal e com abertura para baixo, facilitando a circulação do vapor;
- ✓ Não utilizar caixas que não possuam perfurações ou escotilhas para entrada do vapor;
- ✓ Fechar a autoclave verificando se houve completa vedação da porta;
- ✓ Ligar a autoclave conforme instruções de funcionamento contidas no manual do fabricante;
- ✓ Aguardar o ciclo de esterilização observando se a autoclave atingiu temperatura e pressão recomendado;
- ✓ Ao final do processo de esterilização, entreabrir a porta somente após o manômetro indicar ausência total de pressão no aparelho (0 mmHg), mantendo-a aberta por pelo menos 10 minutos para secagem completa do material;
- ✓ Retirar o material da autoclave utilizando EPI adequado para evitar queimaduras (aguardar o resfriamento completo);
- ✓ Verificar integridade das embalagens e coloração de fita adesiva para autoclave (zebrada) (indicador multiparamétrico externo) – deverá estar escura em relação à fita não exposta à esterilização;
- ✓ Retirar da carga o pacote desafio e verificar a situação do integrador classe 5. A linha de chumbo deverá ter atingido, no mínimo a entrada da faixa de aceite para considerar a carga segura;
- ✓ Encaminhar o material estéril para o armário de estoque, organizando de modo que os pacotes com prazo de vencimento menor, fiquem na parte da frente do armário, e os com maior prazo de validade no fundo, evitando vencimento da esterilização;
- ✓ Registrar no formulário de controle de esterilização data de esterilização, hora de início, descrição da carga, número do ciclo, término do processo, lote e anexar o integrador classe 5, correspondente à carga.

Cuidados especiais

- ✓ Não esterilizar materiais têxteis e caixas de instrumentais na mesma carga. Caso isso não seja possível, os materiais têxteis deverão ser colocados na parte superior e os instrumentais na inferior;
- ✓ Dispor os pacotes de modo vertical para facilitar a entrada e a circulação do vapor, permitindo a exposição do material à temperatura e ao tempo previsto, bem como a eliminação do ar. Essa disposição correta na autoclave evita a ineficiência da secagem da carga;
- ✓ A carga na autoclave deve ser distribuída de uma maneira uniforme e não deve tocar as



- paredes do equipamento por risco de queimar as embalagens;
- ✓ Se possível e disponível, utilizar cestos aramados para a colocação de pacotes;
 - ✓ Os pacotes com grau cirúrgico devem ser posicionados para que o lado do filme transparente esteja em contato com o lado do filme transparente do outro pacote. Da mesma forma, as superfícies de papel devem estar em contato entre si. Isso evita a absorção no papel da água condensada no lado plástico;
 - ✓ Utilizar no máximo 80% da capacidade da câmara do equipamento;
 - ✓ Seguir as normas de funcionamento do equipamento;
 - ✓ Realizar inspeção da autoclave antes de cada ciclo, e garantir o funcionamento adequado antes de iniciar o processo com a carga de material;
 - ✓ Registrar todo o processo de esterilização do início ao fim do processo (tempo, temperatura, pressão), a fim de garantir a análise do processo posteriormente;
 - ✓ Em todos os casos de manutenção, troca de local de instalação ou mau funcionamento das autoclaves, o equipamento deve ser submetido a teste no primeiro ciclo após manutenção com indicador biológico e químico, obrigatoriamente;
 - ✓ Os pacotes, após um ciclo completo de esterilização, devem ser resfriados naturalmente, antes do manuseio;
 - ✓ Evitar a retirada dos pacotes da autoclave até o completo resfriamento. Quando não for possível, atentar-se para não dispor os pacotes sobre superfícies frias após a esterilização para que não haja condensação;
 - ✓ Sempre que necessário a retirada dos pacotes ainda aquecidos da autoclave, utilizar luvas de proteção;
 - ✓ Desligar o equipamento para a limpeza da câmara interna com água e sabão (diária ou semanal), conforme a rotina e frequência de cada unidade, e registrar a realização da rotina;
 - ✓ Quando a fita adesiva para autoclave (zebrada) não estiver com tarja escura, o artigo deve ser considerado não estéril e o processo de embalagem e esterilização deve ser refeito;
 - ✓ Reprocessar os pacotes com identificação danificada, salvo se o problema for identificado logo após a retirada da autoclave (nestes casos, refazer a identificação antes de guardar o material);
 - ✓ Quando o integrador não atingir a faixa mínima de aceitação, o enfermeiro deve ser comunicado e a autoclave deve passar por processo de manutenção. O ciclo deverá ser cancelado e reprocessado em outro equipamento (usar equipamento de unidade próxima, para evitar grandes trajetos com o material já esterilizado) todos os produtos presentes em cargas cujos parâmetros não foram atingidos;
 - ✓ Sempre que houver falha nos processos, desativar o equipamento e acionar a manutenção do equipamento pela engenharia clínica pelo portal de serviços;
 - ✓ O teste com indicador biológico deve ser feito semanalmente, no ponto de maior desafio da autoclave, com leitura e entrega de resultados conforme POP – Rotina nº 20 – Monitoramento químico e biológico da esterilização;
 - ✓ Se a carga for liberada antes dos resultados do indicador biológico e, posteriormente, este indicar falha no processo, todos os materiais, desde a última carga, deverão ser recolhidos e considerados não estéreis, desativar o equipamento e acionar a manutenção do equipamento se a leitura do indicador for positiva.

1.5 Armazenamento dos materiais

Devem ser acondicionados em local limpo e seco, sob a proteção da luz solar direta, e submetidos à manipulação mínima. Devem ser armazenados de forma organizada, preferencialmente em prateleiras fechadas e exclusivas com acesso restrito.

Recomendações

- ✓ Manusear os pacotes quando estiverem completamente frios, antes de estocá-los ou removê-los da autoclave;
- ✓ Estocar os produtos esterilizados em local de acesso restrito, separados de itens não estéreis, em ambiente bem ventilado;
- ✓ Proteger os produtos de contaminação, danos físicos e perdas durante o transporte, utilizando recipiente rígido com tampa e limpo sempre que necessário o transporte para uso ou armazenamento;
- ✓ Fazer a estocagem dos pacotes dos artigos de modo a não comprimir, torcer, perfurar ou comprometer a sua esterilidade, mantendo-os longe de umidade;
- ✓ Estocar os materiais organizando de modo que os pacotes com prazo de vencimento menor, fiquem na parte da frente do armário, e os com maior prazo de validade no fundo, evitando vencimento da esterilização.

A perda da esterilidade de um material embalado associa-se tanto ao evento relacionado ao produto, quanto ao tempo de esterilização. Portanto, NÃO utilizar os artigos que apresentarem as seguintes alterações:

- ✓ Pacotes amassados, rasgados, torcidos;
- ✓ Pacotes que caírem no chão;
- ✓ Invólucro com umidade ou mancha;
- ✓ Suspeita de abertura da embalagem;
- ✓ Prazo de validade expirado;
- ✓ Presença de sujidade no pacote ou no material.

Para garantirmos a segurança e eficácia da esterilização, recomendamos os seguintes prazos de validade da esterilização:

Quadro 04 – Prazo de validade dos pacotes, conforme embalagem e unidade de empacotamento (considerar somente embalagens integras)

Embalagem	CME Hospitalar	Outras Unidades
Grau Cirúrgico	180 dias	120 dias
Papel Crepado	30 dias	30 dias

Fonte: Brasília, 2001

2 Controle e monitoramento dos processos

O controle dos processos é de responsabilidade de quem executa o processo de limpeza, embalagem, esterilização e armazenamento, iniciando e finalizando o processo da autoclave, e deve ser supervisionado pela chefia imediata regularmente.

Todo material submetido a processamento (limpeza, desinfecção e esterilização), deve ser submetido a inspeção visual e ter o processo controlado quando for submetido a esterilização.

São etapas do processo de monitoramento e controle: limpeza, desinfecção química líquida, preparo e empacotamento, esterilização, controle físico, controle químico e controle biológico.



Notas

- Os resultados e registros dos processos físicos, químicos e biológicos, devem ser arquivados por 5 anos e com ciência do enfermeiro, independente da carga ter sido aprovada ou não;
- São atribuições do auxiliar de enfermagem/técnico de enfermagem: limpeza, desinfecção, preparo, empacotamento e esterilização;
- O enfermeiro deve monitorar e supervisionar os processos realizados pelo auxiliar de enfermagem /técnico de enfermagem.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS. **Protocolos de Segurança do Paciente I**. Módulo 2. Unidade 4. Processamento de Produtos para Saúde. Brasília/DF: 2018.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução – RDC nº 15, de 15 de março de 2012**. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Brasília – DF: 2012.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução – RE nº 2.606, de 11 de agosto de 2006**. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração, validação e implantação de protocolos de reprocessamento de produtos médicos e dá outras providências. Brasília – DF: 2006.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução – RE nº 2.605, de 11 de agosto de 2006**. Estabelece a lista de produtos médicos enquadrados como de uso único, proibidos de ser reprocessados. Brasília – DF: 2006.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação Geral das Unidades Hospitalares Próprias do Rio de Janeiro. Divisão de Controle de Infecção Hospitalar. **Central de Esterilização – Manual**. Brasília – DF: 2001.
6. CAMPINAS. Secretaria da Saúde. Diretoria do Departamento de Saúde. Coordenação de Enfermagem. **Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Produtos para a Saúde**. Campinas – SP: 2021.
7. City Wide Infection Control Team Leeds North East PCT. Guidelines for the Local Decontamination of Reusable Medical Equipment. 2005.
8. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DO CENTRO CIRÚRGICO (SOBECC). **Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização**. Práticas Recomendadas – SOBECC. São Paulo – SP: 2013.

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2013 Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica	2023 Fabiane Cherobin Gabriela Cristina da Silva Brandão Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2

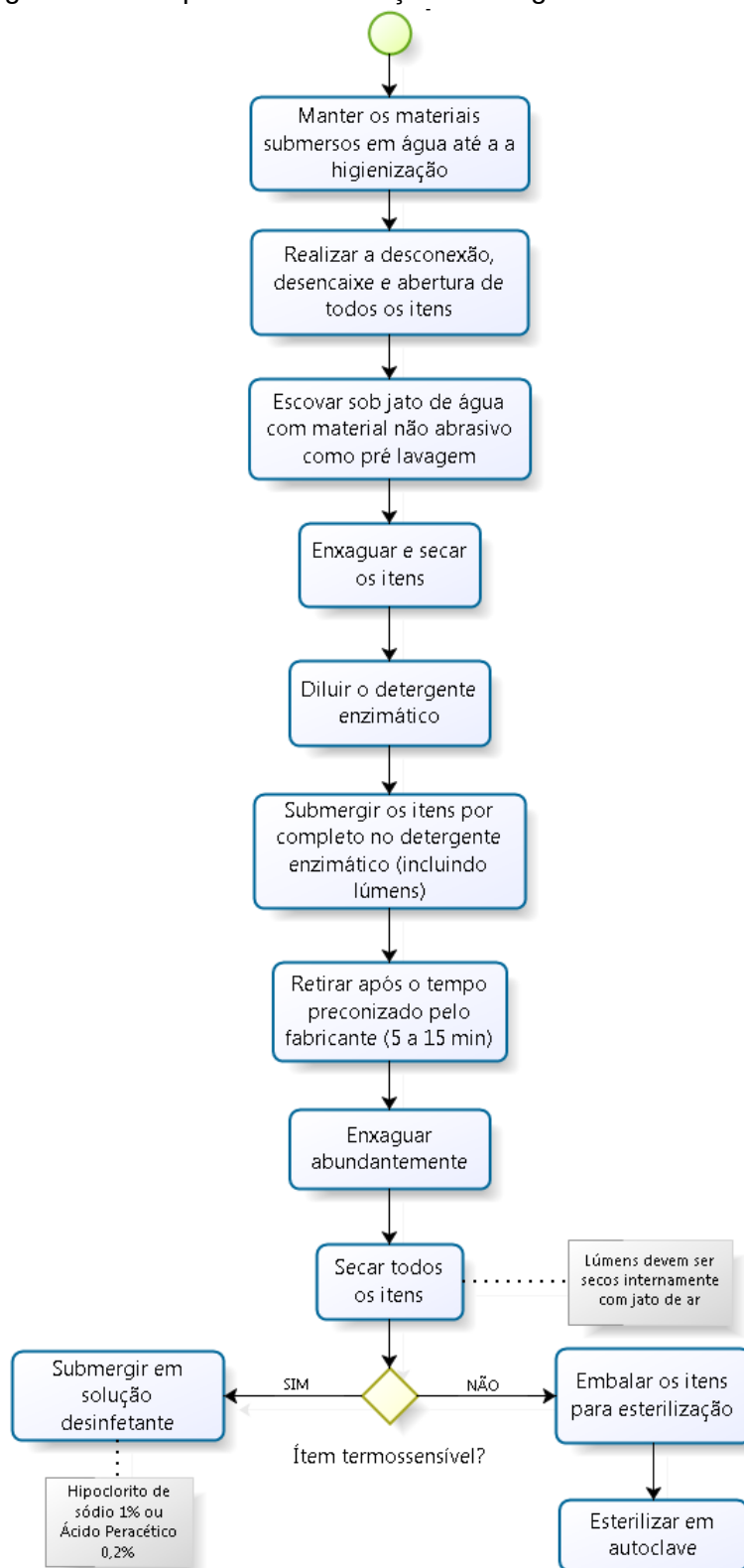
Wiki da Prefeitura – <https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:Saúde>



Alteração após Revisão			
Versão	Data	Responsável	Alteração
02	2023	Manuelle Hölscher Belz	• Correção e atualização do texto; • Alteração dos prazos de validade da esterilização; • Inclusão de quadro 03 com orientações sobre montagem dos pacotes; • Inclusão de recomendações sobre o armazenamento de materiais; • Inclusão do fluxograma.



Apêndice 01 – Fluxograma de Limpeza e Desinfecção de Artigos



Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial (NGA), 2023

